

PERIODONCIA

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, le presentamos para su firma el siguiente documento:

D./Dña., con documento, como paciente, declaro que el Dr./la Dra., con número de colegiado, me ha diagnosticado:

El paciente es menor de edad. Consigne a continuación el nombre y documento del padre, madre o tutor que presta el consentimiento en su representación.

Nombre y apellidos:

Documento de identidad:

Parentesco o relación con el paciente:

Para dicho diagnóstico me ha propuesto y presupuestado el siguiente plan de tratamiento:

Piezas:

En relación con el diagnóstico, el facultativo me ha explicado, y comprendo, que:

Los procedimientos propios de la periodoncia van dirigidos al tratamiento de las patologías específicas del sistema de soporte dentario, la enfermedad periodontal, que comprende desde una ligera inflamación de la encía hasta la pérdida de dicho sistema de soporte (formado por la encía, ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular) intentando conservar al máximo las estructuras dentarias y su función. La enfermedad periodontal es un proceso de curso crónico en el que intervienen factores infecciosos, hereditarios, inmunológicos, etc. Por tanto la mejoría obtenida mediante el tratamiento nunca se podrá considerar como definitiva porque dependerá del mantenimiento de la higiene por el propio paciente y de otros factores de muy difícil control (inmunológicos, hormonales, etc). Dentro de estos procedimientos propios de la periodoncia se incluyen desde los raspajes y alisados radiculares hasta toda la gama de cirugía periodontal realizada con distintos procedimientos para tratar el hueso, la encía o facilitar los procedimientos higiénicos al paciente. También se incluyen toda una serie de procedimientos de estética gingival. No existe alternativa terapéutica para el tratamiento de esta patología distinta al tratamiento periodontal.

Factores de riesgo

- El mal control de placa: sin una correcta técnica de cepillado que elimine los depósitos bacterianos de dientes y encías, el control de la periodontitis no es posible
- El tabaco es un conocido factor agravante de la enfermedad periodontal, por lo que el fumar conlleva una respuesta peor a los tratamientos, y un mayor riesgo de agravamiento de su evolución normal y de reactivación de la enfermedad
- Algunos medicamentos como los anticomociales, algunos inmunosupresores y los bloqueantes de los canales del calcio, entre otros. Por ello comprendo que es importante comunicar todos los antecedentes clínicos y tratamientos farmacológicos en curso

Cronicidad

Por todo lo dicho, la enfermedad periodontal no cura (salvo raras excepciones), aunque en la gran mayoría de los casos puede mantenerse detenida mediante tratamiento odontológico si existe una buena cooperación del paciente en el mantenimiento de una buena higiene oral.

En ocasiones no existe más posible tratamiento que la extracción de uno o más dientes, para evitar la propagación de la enfermedad o eliminar la sintomatología de dientes muy afectados.

Además, para poder controlar y frenar la evolución de la enfermedad periodontal es imprescindible, aparte de una cuidadosa higiene oral personal, la realización de visitas periódicas de control y mantenimiento, consistentes en profilaxis (limpiezas) y ocasionales raspados de las irregularidades que los depósitos microbianos provocan en las superficies de las raíces.

Limitaciones y riesgos

El/a paciente ha sido informado/a y conoce los riesgos estadísticamente frecuentes que puede comportar este tratamiento:

- Riesgos propios de la inyección de anestesia local: posibles hipersensibilidades al anestésico difícilmente previsibles, anestесias prolongadas, daños locales por la punción, excepcionalmente dolores neuropáticos, etc
- Riesgo de aumento de la movilidad dentaria, habitualmente recuperable tras estos tratamientos
- Riesgo de aumento de la sensibilidad dental y de molestias en la zona tratada, también por lo general recuperables ambas. E
- Alteraciones en la estética dentogingival: cualquier tratamiento periodontal, y sobre todo si es quirúrgico y conlleva la eliminación de tejidos enfermos, puede provocar cambios importantes en la estética dental. La alteración más frecuente es la retracción gingival que provoca la sensación de alargamiento de la corona del diente, habitualmente no reversible
- Encaso de cirugía periodontal existen los riesgos específicos de todo procedimiento quirúrgico: dolor, inflamación, hemorragia, hematoma, sobreinfección de la zona, dehiscencia de suturas,
- Riesgo de fracaso de los procedimientos estéticos mucogingivales (de las encías)
- Riesgo de rechazo de los tejidos o materiales injertados (óseos, gingivales, etc)
- Existe siempre el riesgo de reactivación de la enfermedad periodontal que puede deberse a una higiene incompleta o a factores intrínsecos del paciente difícilmente controlables

Riesgos personalizados

Asimismo, D./Dña., por sus especiales condiciones particulares, puede presentar riesgos añadidos consistentes en:

Contraindicaciones

He informado al facultativo de mi estado de salud, de las enfermedades que padezco o he padecido, de la medicación que tomo actualmente y de mis alergias conocidas. Comprendo que determinadas condiciones médicas, tratamientos farmacológicos o hábitos pueden desaconsejar este tratamiento, obligar a modificarlo o empeorar su pronóstico, y que el facultativo me ha explicado si alguna de ellas concurre en mi caso.

Contraindicaciones específicas advertidas en mi caso:

Yo, D./Dña., como paciente, he sido informado/a por el Dr./la Dra., comprendo el alcance y el significado de dicha información, he podido formular cuantas preguntas he considerado oportunas y se me han aclarado todas las dudas, y consiento en someterme al procedimiento clínico descrito en este documento.

También he sido informado/a de la posibilidad de revocar este consentimiento por escrito y en cualquier momento, sin necesidad de expresar el motivo, incluyendo las posibles consecuencias que conlleva el no someterse al tratamiento propuesto, así como los riesgos que de esta decisión pudieran derivarse en relación con mi salud bucodental.

Información sobre protección de datos

Responsable: CLINICA IMPLANTDENT SL, CIF B17962564, con domicilio en Carrer de Santa Eugènia, 2. Finalidad: la prestación de asistencia odontológica y la gestión de su historia clínica. Legitimación: el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva, diagnóstico médico y prestación de asistencia sanitaria (art. 9.2.h del Reglamento (UE) 2016/679), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales del centro.

Conservación: su historia clínica se conservará durante los plazos legalmente establecidos, con un mínimo de quince años desde el alta de cada proceso asistencial. Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal o cuando resulte necesario para su asistencia. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a info@dentalimplantdent.com, así como presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En Girona, a

El paciente

El odontoestomatólogo informante